



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : غير عرفه صبيح عرفه

المحافظة : الجيزه الحي / المدينة : الهرم

العنوان : ش شيراتون - المنشيه
- الثلاث طوابق

رقم البطاقة : 27406230102005 رقم التليفون : 01142918746 تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 23-06-1974 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض
بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عبير عرفه صبيح عرفه National ID: 27406230102005	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

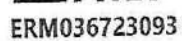
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

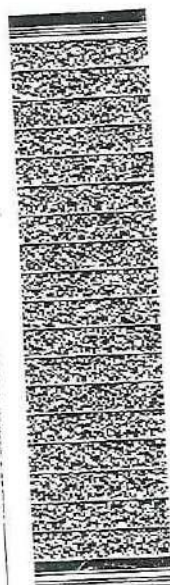


٢٧٤٠، ١٠٢٠، ١٢٣٠، ٢٧٤٠

متر و جہ

[illegible]

البطاقة مسارية حتى ٢٠٢٨/٠٤/١٨



طالعی که در این روز متولد شود، در هر حال در دنیا به آرزوهای خود می‌رسد.

卷

১৯৫৬ চন্দ্রাবতী

٤ ٣ ثب شمبر اتون - المنيبية - الثلاث طواقي

الطهرم - الجيزه

[illegible]

IW6176390

Patient's Name: Abeer Arafa Sabeih Arafa
Date: 2026-05-24
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

- Normal CT appearance of the pancreas, both kidneys , aorta and IVC.
- Still noted left adrenal lesion measuring 13 x 13 mm likely adenoma.
- Normal CT appearance of the spleen .
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses .
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- No worrisome lytic or sclerotic bony lesions
- No vertebral structural collapse .

OPINION:.

Overall stationary course since the last study

Dr.Reham Khedr, MD

Dr.Rahma Khader

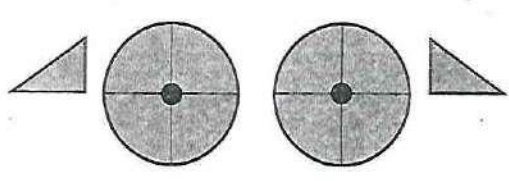
Dr.Rahma Khader

MDT FORM

4/ 11 / 2022 G

Name	جيسر لوفة صبح كوفة	MRN	1345/2022
Age	51	ID	1142918746
Menopausal status	Peri-menopausal	Phone	
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	

Clinical Data

BX: IDC				R L  TNM 0 0 1 bony lesion R+acromioclavicular process
ER: 618	PR: 018	HER 2: +3	Ki67:	
Sonomammography:				
Mets Workup: NACH TCAP x6 diagnosed 10/22 Rt. WLC + ALW → CR → HP 1 year 8123 1124 → Rt + shoulder pain				

Recommendations: rt acromioclavicular process. bone marrow process.
CT chest free. Abd & pelvis → free
PGTCT 8124 → single Rt + acromioclavicular lesion
received Taxol / Herceptin + RT to max since 1/25 → 3/2
Then stopped Taxol Currently on Herceptin last 1/11
251 to 123

MDT OUTCOME & PLAN MDT for adding Hormonal HT + Zoledronic acid
251 to 123 CTCAP → negative
Plan: Herceptin + A for acromioclavicular lesion MDT for metastatic
(1) Zoledronic acid

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. جاسر					

Patient Name : الأستاذ / عبير عرفه صبيح عرفه
Patient No. : 27406230102005
Path No. : 3206/22
Sex : Female
Age : 48 Y
Referring Doc :
Request No. : 13003687
Request Date : 26/10/2022
Verification Date : 07/11/2022
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : dr.Enas

Pathology Report

Clinical Data :

Left breast cancer post NACT

Nature of the specimen :

Left WLE and axillary dissection specimens.

Gross Examination:

Left WLE specimen measured 8x8x1.5 cm , with covering skin ellipse measured 6x1.5 cm
• Tumor extent : An ill defined firm greyish white tumor bed site
• Size: 2x1.5 cm

• Skin involvement: unremarkable grossly
• Distance from margins: Encroaching inferior margin
• Lymph nodes number and size:

2-(ALND): Fibrofatty tissue piece measured 5.5x5 cm enclosing 10 nodules up to 1.5x0.5 cm .
3-Extra inferior margin: Fibrofatty tissue piece measured 5x4x1 cm, free of gross indurations
• Frozen section
-Free margins

Microscopic examination:

- Histological type: Total tumor regression in a previously diagnosed carcinoma
- DCIS: Focal (in one duct)
- Angioinvasion: No
- Lymph node involvement: Free (0/10)
- Skin involvement : Free
- Resection Margins: Free resected margins
- Histologic response to therapy: Pathologic complete response

Diagnosis:

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 26/12/2022 13:58:10

Page 1 of 2

Printing By : dr.Enas

Patient Name	: الأستاذة / عبير عرفه صبيح عرفه	Request No.	: 13003687
Patient No.	: 27406230102005	Request Date	: 26/10/2022
Path No.	: 3206/22	Verification Date	: 07/11/2022
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: dr.Enas

Pathology Report

Left Breast cancer , post NACT ,WLE and ALND specimens :
Pathologic complete response in a previously diagnosed invasive carcinoma
-Focal insitu component (in one duct)
-Free resected margins
-Free lymph nodes (0/10)
-Stage : ypTis, ypN0

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Marwa Mahmoud

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 08/11/2022 10:42:01

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

PATIENT NAME: ABEER ARAFA SABEEH ARAFA
GENDER: Female
AGE: 47 y

PATIENT ID #: 2022188373
ORDER #: 1569181, 1569182
DATE OF SERVICE: 14-Apr-2022 09:28 AM

Report: - all studies

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS

1- CHEST

- Left breast irregular spiculated mass lesion measuring 41 X 29 mm.
- Enlarged left axillary level I and II lymph nodes the largest measures 41 X 29 mm.
- No sizable pulmonary nodules.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Azygous lobe and fissure (normal anatomical variant)

2- ABDOMEN AND PELVIS

- The liver is enlarged with heterogenous low CT texture. No definite sizable focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Left adrenal hypodense nodule measuring 14 X 10 mm mostly adenoma.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and right suprarenal gland.
- Underfilling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

- THE SCANNED SKELETON:

Patient Name: Abeer Arafa Sobaih Arafa	Date : 07/12/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 51 Year(s)
Medical ID: 1575/2022	Pat. ID: 21143

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS

REVEALED:

Status follow up as reviewing the previous CT chest report dated 9-4-2025

I- CHEST:

- Still noted left minimal breast skin thickening.
- Still noted left upper lobar and lingual subpleural reticulations likely post therapy sequel
- No sizable pulmonary nodules, masses, consolidation, collapse or cavitary lesions.
- No sizable hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- No gross cardiomegaly.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous low parenchymal attenuation with still noted relatively hyperdense areas (likely of fat-sparing) at segment VIII No focal lesion or dilated biliary radicles.
- Still noted left adrenal well-defined hypodense nodules .1.3x 1.3 cm likely adenoma
- Small fat containing umbilical hernia.
- Normal C.T appearance of the spleen, both kidneys, right adrenal glands, pancreas, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No ascites.

Opinion:

Status follow up show rather stationary course since last study.

Patient's Name: Abeer Arafa Sabeih Arafa
Date: 2026-09-09
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction. IV contrast was used.

FINDINGS:

Clinically reported left breast carcinoma , compared to last study dated 24-5-2026, the current study showed:

(I) Chest:

- Left upper lobe and lingula subpleural reticulations
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes .
- Clear both lung fields .no sizable pulmonary masses or consolidation patches
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size showing diffuse low CT attenuation no focal lesion.
- Patent and homogenously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the pancreas, both kidneys , aorta and IVC.
- Still noted bulky left adrenal gland.
- Normal CT appearance of the spleen .
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses .
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-cruel, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Still noted right iliac bone small lytic area.

OPINION:-

Stationary course since the last study